

32 - 03-Sémiologie cardiovasculaire : Dyspnée - Pr. L. Bendriss

Bonjour, aujourd'hui on va essayer de traiter la dyspnée, comme son nom l'indique vous avez dys ça veut dire difficulté épinée, difficulté de respirer. C'est quoi la dyspnée? C'est une prise de conscience parce que normalement quand on respire, c'est une respiration qui est inconsciente. Quand on commence à prendre conscience de cette respiration, ça veut dire que c'est une respiration qui est difficile, qui exige un effort supplémentaire pour pouvoir respirer et du coup on va sentir une sensation de soif, ça veut dire que l'air qu'on respire n'est pas suffisant.

Normalement la respiration, comme je vous ai dit, est inconsciente et la fréquence respiratoire classique est de 14 à 16 cycles par minute chez l'adulte et un peu plus chez enfant. Et selon la pathologie sous-jacente qui serait responsable, soit c'est une dyspnée qui est brutale ou aiguë, soit qu'elle est progressive dont le temps est chronique et puis les circonstances de surveillance pourraient être soit d'effort ou de repos. Encore une fois la dyspnée c'est une sensation de manque d'air, donc on a toujours besoin d'air, on sent que l'air qu'on respire est insuffisant.

Elle va se traduire par un essoufflement et une tachypnée superficielle. Tachypnée c'est l'accélération de la fréquence respiratoire et qui est superficielle, n'est pas profonde pour satisfaire ce manque d'oxygène. Alors si d'origine cardiovasculaire, si la dyspnée est d'origine cardiovasculaire, elle va être liée, quels seraient les mécanismes de la dyspnée d'origine cardiaque? C'est l'augmentation de la pression capillaire pulmonaire qui va faire diminuer la compliance, si vous voulez dire l'extension des poumons.

Ceci va créer une hypoxémie et une acidose lactique. Alors je vais vous rappeler très brièvement la circulation pulmonaire, donc ça va de l'artère pulmonaire qui est du ventricule le droit, puis les artères pulmonaires qui vont suivre un petit peu la segmentation branchique, puis on va y arriver au niveau des artérioles, puis les capillaires pulmonaires qui sont situés à proximité des alvéolis qui vont nous assurer les échanges alvéolo-capillaires pour l'hématose et puis le relais va être pris par les vénules, les veines pulmonaires au nombre de 4 qui vont se jeter dans l'oreillette gauche. Alors si vous avez une cardiopathie gauche, une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire un cœur gauche qui est défaillant, ça va entraîner une augmentation des pressions télé-diastoliques du ventricule gauche qui vont être transmises à l'oreillette gauche en amont, puis l'augmentation de la pression intra-auriculaire gauche va être transmise de manière passive au niveau des veines pulmonaires et puis l'augmentation des pressions au niveau des veines pulmonaires va être transmise au niveau des capillaires pulmonaires, donc c'est l'augmentation de la pression capillaire pulmonaire et c'est une pression qui est hydrostatique et vous savez qu'il y a deux pressions qui règnent au niveau des vaisseaux, vous avez la pression hydrostatique et puis vous avez la pression oncotique qui retient du liquide à l'intérieur du vaisseau grâce aux protéines.

Alors une fois que vous avez cette pression hydrostatique qui va augmenter, donc ça va limiter la température pulmonaire et plus elle va augmenter, elle peut facilement dépasser cette pression oncotique et quand elle va la dépasser, vous avez du liquide qui va sortir du capillaire vers les

alvéoles et la forme extrême serait l'inondation alvéolaire ou l'œdème aigu du poumon qui serait responsable de cette dyspnée d'origine cardiaque. Pour ceci, on a besoin d'analyser de manière très simbologique la dyspnée pour essayer de s'orienter vers l'éthiologie, donc la dyspnée comme vous savez c'est un signe subjectif qui est rapporté par le patient, donc il faut faire un interrogatoire très soigneux et très méticuleux pour pouvoir un petit peu analyser ces dyspnées. D'abord la date du début, le mot du début, est-ce qu'il est brutal ou progressif, les circonstances d'apparition, c'est important, est-ce qu'elle est spontanée, induite par l'effort, donc l'origine cardiaque, la saison probablement c'est un âge cardiaque, l'évolution dans le temps, est-ce qu'elle est permanente ou elle survient par paroxysme, c'est-à-dire des crises, l'horaire, est-ce qu'elle est dure le jour ou nocturne la nuit, puis l'existence de signes accompagnateurs vont nous orienter vers l'éthiologie causale.

Alors on commence par le mot du début, soit c'est une dyspnée aiguë, ça veut dire qu'elle est brutale, elle est maximale, soit c'est une dyspnée chronique qui évolue dans le temps avec un début progressif le plus souvent. Alors selon les circonstances d'apparition, soit c'est une dyspnée d'effort, donc elle est induite à l'effort, donc on peut évaluer la sévérité par l'évaluation du seuil ou par la quantité d'effort, soit par les étages, soit le nombre de marches, soit des fois pour un effort moindre de la vie quotidienne tel qu'un effort d'habillage, ces dyspnées pourraient être de repos carrément spontané ou évoluer vers une dyspnée de décubitus ou orthopnée. C'est quoi l'orthopnée? C'est une dyspnée qui survient en position couchée et qui oblige le patient à se mettre en position assise pour qu'il soit soulagé.

Alors là je vous rapporte le tableau de la classification de la New York Heart Association ou la NIA, c'est une classification de la dyspnée d'origine cardiaque qui est classée en 4. 1, c'est une dyspnée pour des efforts importants, inhabituels, des fois assez difficiles, un petit peu de aucune gêne dans la vie courante. Dyspnée 2, c'est pour des efforts importants mais qui sont habitués par exemple à monter de plus de deux étages ou monter dans une côte ou une pente. Dyspnée 3, c'est une dyspnée pour des efforts de la vie quotidienne tels que l'effort d'habillage, le fait d'aller aux toilettes, le fait de se coiffer, d'accord? Et puis la dyspnée 4, c'est une dyspnée qui est permanente de repos ou orthopnée.

Autre critère d'analyse de la sémiologie de la dyspnée, selon le rôle d'évolution, soit c'est une dyspnée paroxystique donc par paroxysme ou par crise, soit c'est une dyspnée permanente donc qui va être d'une dyspnée qui peut commencer par une dyspnée d'efforts puis évoluer après à une dyspnée de repos et puis des fois une dyspnée de décubitus qui est l'orthopnée. Selon la fréquence respiratoire, c'est une polypnée, c'est-à-dire l'accélération de la fréquence respiratoire, soit c'est une bradypnée au contraire, ça veut dire une diminution de la fréquence respiratoire. Et puis enfin, selon le temps respiratoire, soit c'est une dyspnée inspiratoire, soit qu'elle est expiratoire.

Alors, les tableaux cliniques de la dyspnée cardiaque, alors cette fois-ci on va être dans la

dyspnée cardiaque et il faut savoir que ça évolue depuis la dyspnée d'efforts jusqu'à la dyspnée de repos. Alors la dyspnée d'efforts, c'est une polypnée superficielle, donc on va sentir la sensation du manque d'air. C'est un principal signe d'insuffisance cardiaque gauche qui va faire augmenter la pression capillaire pulmonaire et on peut évaluer sa sévérité par la précédente classification qui est la classification de l'ANIA.

Et puis par la suite, comme autre tableau clinique révélateur qui va être un petit peu l'évolution de la dyspnée d'efforts, c'est la dyspnée de décubitus ou l'orthopnée qui est une aggravation de ces insuffisances cardiaques gauche et l'orthopnée on peut évaluer sa sévérité par le nombre d'oreillers que le patient va adosser. Sur ce fond de dyspnée chronique précédente, ça veut dire où le patient est toujours compensé, peut se greffer des paroxysmes et donc le patient est en train de décompenser son insuffisance cardiaque sous forme de dyspnées paroxystiques au nocturne, donc le patient est déjà orthopnéique mais soudainement il va ressentir des paroxysmes, il va être exagérant de ses dyspnées avec suffocation et tout. Et cette fois-ci ces dyspnées ou ces paroxysmes ne cèdent pas à la position acide donc le patient a besoin d'un dérivénitré qui est un vasodilatateur veineux pour diminuer le retour veineux et soulager la circulation pulmonaire.

La forme extrême dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'œdème aigu du poumon et comme forme clinique de cet œdème aigu du poumon, c'est le pseudoasthme cardiaque, c'est-à-dire au lieu d'avoir une inondation alvéolaire, on va avoir une inondation péri-branchique qui va mimer l'asthme respiratoire. Alors le tabou clinique complète de l'œdème aigu du poumon, c'est un œdème alvéolaire dit eux, généralement le début il est aigu et généralement c'est la nuit, c'est une urgence médicale parce qu'il y a un risque d'asphyxie. Alors les signes fonctionnels ou les signes de l'interrogatoire, c'est un fond d'orthopnée sur lequel va se greffer une dyspnée aiguë avec une perception de grésillement, de grattage dans le larynx, une touquette incessante avec des expectorations qui ont une couleur rose saumonée et qui sont lousseuses et puis les signes accompagnateurs, c'est les signes d'hyperactivation, une sympathie avec la peur, c'est l'angoisse extrême, les sueurs et une sensation de mort imminente à cause de l'asphyxie.

Les signes physiques ou les signes de l'examen clinique de l'œdème et du poumon, c'est un patient qui est généralement assis, jambes pendantes en bas pour diminuer le retour veineux et soulager la circulation pulmonaire, c'est un patient qui est agité avec des signes de lutte respiratoire à cause de l'hypoxie et puis les tachypnées, c'est-à-dire une respiration qui est rapide, cyanosée parce que vous avez un problème d'hématose donc une coloration qui est bleuâtre avec des sueurs froides et à l'ostultation pulmonaire vous aurez des râles crépitants qui ressemblent un petit peu à la crépitation donc la sensation quand vous crépitez vos cheveux donc vous allez sentir ce que c'est que la crépitation, c'est des râles crépitants qui vont envahir de bas en haut les deux champs pulmonaires en la définissant comme une marée montante. Alors tout ce qui est noté chez vous dans cette signologie annexe, vous passez en compas, on passe aussi. Alors la dysmnie, on va voir un petit peu les étiologies, quelles seraient les

étiologies cardiaques, c'est essentiellement l'insuffisance cardiaque gauche dont je vous ai parlé avec une dyspnée progressive qui répond à la classification de la NIA et qui va s'améliorer sous traitement, notamment les traitements de l'insuffisance cardiaque, on va voir les diurétiques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et puis les pépaloïdes qui sont des traitements de fond de l'insuffisance cardiaque et puis comme forme aiguë de l'insuffisance cardiaque, c'est le système aigu pulmonaire avec une dyspnée brutale expectoration rosse au monnaie et puis comme autre étiologie de la dyspnée d'origine cardiaque, vous avez la péricardite qui est l'inflammation du feuillet qui enveloppe le cœur, donc c'est une dyspnée qui est permanente, qui est soulagée généralement quand le patient penche en avant, donc l'antéflexion, elle est généralement associée à la douleur thoracique et une fièvre.

Alors les autres causes de la dyspnée, c'est-à-dire des causes non cardiaques pour pouvoir poser votre diagnostic différencié, c'est tout ce qui est d'abord broncho-pulmonaire, donc vous avez l'embolie pulmonaire d'abord, c'est une dyspnée qui est brutale et vous avez un contexte qui va prédisposer à faire l'embolie pulmonaire, on va le voir plus tard dans les cours qui viennent, donc l'alimentation prolongée, l'immobilisation qui va favoriser la maladie thrombotique veineuse et puis comme deuxième étiologie dans les dyspnées d'origine broncho-pulmonaire, vous avez tout ce qui est asthme cardiaque, vous avez tout ce qui est infection bronchique, les obstructions bronchiques, pneumothorax et pneumonie et puis on pourrait avoir un obstacle sur les voies aériennes par un goitre par exemple thyroïdien qui va créer une compression extrinsèque de la trachée. Autre étiologie de la dyspnée, donc toujours dans le diagnostic différentiel par rapport à la dyspnée d'origine cardiaque, c'est tout ce qui est atteinte neuromusculaire, donc des traumatismes thoraciques qui vont entraver l'expansion thoracique et puis tout ce qui est atteinte neurologico-musculaire, la myasthénie, la polyradiculoneuropathie qui va un petit peu avoir un effet sur les muscles respiratoires et être un petit peu dans la difficulté d'avoir cette expansion thoracique pour pouvoir respirer. Puis comme autre étiologie, donc tout ce qui est métabolique, l'anémie, vous aurez une dyspnée à cause un petit peu, donc on augmente la fréquence respiratoire pour pouvoir pallier à ce manque d'oxygène.

Puis les autres étiologies, la grossesse, une obésité importante, la déshydratation et la fièvre peuvent entraîner une dyspnée. Et en dernier lieu, vous avez une dyspnée psychogène, c'est un terrain qui est généralement émotif et ceci a préservé et éliminé tout ce qui est organique et c'est un dernier diagnostic, c'est un diagnostic d'élimination et je vous remercie.